

STEP 2 환자 교육

공감	갑자기 피를 토하셔서 많이 놀랐을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 말로리-바이스 증후군이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 그 외에 역류식도염, 위궤양 등을 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 위내시경검사가 필요하고, 전체혈구검사, 전해질검사 등 혈액 검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 말로리-바이스 증후군이 확진되면 치료를 위해 금식과 수액 치료가 필요하고, 출혈이 심한 경우 내시경적 치료가 필요할 수 있습니다. 만약 식도정맥류 출혈이 확인되면 정도에 따라 내시경정맥류결찰술을 시행할 수 있고, 간경변에 대한 관리가 지속적으로 필요합니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	위내시경을 시행하기 위해서 8시간 이상 금식하셔야 합니다. 출혈이 심하면 어지럼/호흡곤란 등이 발생할 수 있는데, 그럴 경우 응급 상황이니 병원으로 바로 내원하시길 바랍니다. 술을 드시면 상태가 점점 악화될 것이고 재발할 수 있기 때문에 반드시 금주하셔야 합니다. 간경변이 잘 조절되지 않으면 식도정맥류 출혈이 재발할 수 있습니다. 그런 경우 혈관조영술을 통한 시술이 필요할 수 있습니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, 전해질, LFT, 혈액응고검사
- ② 위식도내시경, 요소날숨검사, Chest X-ray, 복부 X-ray, 혈관조영술

❖ 치료 계획

- ① 출혈 : 수액 치료(심하면 수혈)
- ② 내시경적 지혈술, 금식
- ③ 소화성 궤양 : PPI, *H. pylori* 치료
- ④ 식도정맥류 출혈 : 내시경정맥류결찰술, band ligation, 예방적 베타 차단제
- ⑤ 말로리-바이스 증후군 : Bed rest, 수액, 항구토제, 자발적 지혈

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

☞ 환자를 우선 안심시킨 후 어지러움, 호흡곤란 증세 시 응급 상황이니 병원에 오도록 교육합니다.

- ① 피와 관련되었기에 환자 공포감 안심시켜 주기+환자 약제 질문(+ 출혈 경향)
- ② 환자 상태 안정시키기 위해 수액 공급 및 수혈의 필요성 설명하기
- ③ 진단 위해 상부 위장관내시경검사 필요하고 지혈 치료할 수 있음을 설명하기

☞ 응급내시경이 필요한 경우 내시경 전 8시간 금식 유지를 교육합니다.

- ④ 내시경적 지혈 외에도 혈관조영술, 외과적 치료가 필요할 수 있음을 환자에게 설명
- ⑤ 말로리-바이스 증후군 같은 경우 안정 취하고 먹는 것 금함
- ⑥ 모든 상부 위장관 출혈 환자에서 가능한 빨리 상부 위장관내시경 시행하기



keyword

객혈과 감별하기

토혈 양/어지럼증/호흡곤란/소변량 감소 및 수액 필요 유무 파악하기

말로리-바이스 증후군 감별 위해 음주력 물어보기

변 색깔 물어보기

약물력(NSAID, 항응고제 등) 물어보기

신체 진찰 : 간질환 관련 신체 검진(Flapping tremor, 거미혈관종 등) 잊지 않고 시행하기

응급 상황 판단 위해 신체 진찰에서 혈압/맥박 확인하기

식도	정맥류	간 증상, 간 P/E
	MWS	과음
	GERD	속쓰림, 신물
	식도암	체중 감소, 연하곤란, 담배
위	위궤양	속쓰림, 식후 명치 통증 ↑
	십이지장궤양	복통, 식후 명치 통증 ↓
	천공	발열, 오한, 복부 전체 DT/RT
	위암	체중 감소, 소화불량
응고장애		출혈 경향, 항응고제, NSAIDs

시형 광경 코멘트



혈변은 보통 Treitz ligament 이후의 하부위장관 출혈을 의미하며, 선홍색/적갈색 피가 항문을 통해 나오는 것입니다. 혈변의 발생 위치, 출혈 정도, 점액변 여부 등에 따라 기질적 원인을 감별하는 것이 중요합니다.

병력 청취 시 혈변이 발생한 위치와 원인을 파악하고, 원인에 따른 진단, 치료 계획을 수립해야 하며, 출혈 정도를 파악해 응급 상황 여부를 파악해 응급 조치를 할 수 있어야 합니다. 혈변의 색깔을 통해 출혈 부위를 감별하고, 출혈량을 통해 소화관/항문 질환을 감별해야 하며, 반드시 변의 양상에서 점액변 여부를 물어 IBD를 감별해야 합니다. 항문 질환과 감별하기 위해 힘을 주었을 때 덩이 여부, 출혈량, 변비 등을 물어 볼 수 있습니다.

신체 진찰 시 혈압/맥박을 확인해 응급 상황 여부를 가장 먼저 확인해야 합니다. 그 외 결막 등을 확인해 빈혈 여부, 혀, 피부를 관찰해 탈수 여부를 확인해 주고, 복부를 진찰합니다.

환자 교육에서 출혈량이 많은 경우 환자를 안심시키고, 빈혈 소견을 보이는 경우 수액 공급 및 수혈의 필요성을 설명하는 것이 중요합니다. 양성 질환의 경우 식습관, 운동 습관, 배변 습관 등에 대해 구체적으로 교육해 주면 좋을 것 같습니다. 또한 나이가 있거나 위험 인자가 있는 경우 대장내시경을 통해 기질성 질환 감별이 필요하며, 만 50세 이상 시 국가암검진 프로그램에 대해 권유하는 것이 좋습니다. 간혹 진단명이 명확한 경우 추가적인 검사나 대략적인 치료 방법에 대해 환자가 질문하는 경우가 있기 때문에 대표적인 질환에 대한 진단과 치료는 숙지하는 것이 좋습니다.

혈변 증례에서 필수 임상 술기로는 항문 직장 진찰(DRE), 혈압 측정이 해당합니다.

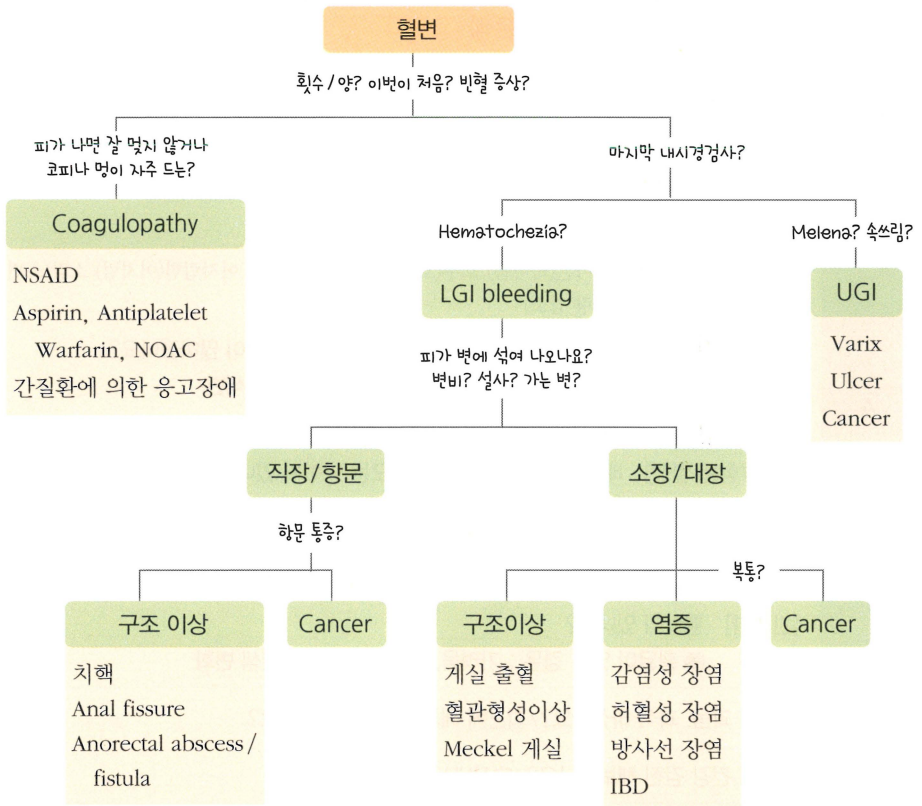
질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
대장 질환	소아 폴립 (juvenile polyp)	[병력] 학동전기 소아, 무통성 선홍색 혈변 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 대장내시경 [치료] 내시경적 폴립절제술
	메켈 게실 (meckel diverticulum)	[병력] 무통성 대량 혈변 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 99m-Tc 적혈구 스캔, 대장내시경 [치료] 수액 공급, 게실절제술

대장 질환	결장암★ / 직장암★	[병력] 많은 양의 혈변, 흑색변, 변 굵기 변화, 변비, 체중 감소 [검진] 복부 종괴, DRE 상 종괴	[검사] 대장내시경, 복부 CT, 복부 MRI [치료] 대장절제술, 방사선 치료, 수술
	개설 출혈★ (diverticular bleed- ing)	[병력] 발열, 복통, 변비, 대변에 피가 섞임 [검진] 복부 압통(RLQ)	[검사] 대장내시경, 복부 CT [치료] 경과 관찰, 수액요법, 항생 제, 금식 → 출혈 계속되면 소장술 또는 혈관조영술
	허혈 결장염 (ischemic colitis)	[병력] 기저 심장 질환, 고혈압, 복통 [검진] 복부 압통(좌측)	[검사] 대장내시경, 단순 복부 방사선 촬영 [치료] 수액 공급 항생제, 금식
	감염성 대장염	[병력] 발열, 설사, 심한 복통, 상한 음식 [검진] 복부 압통	[검사] 대장내시경, 대변배양검사, 단순 복부 방사선 촬영 [치료] 수액 공급 항생제, 금식
	염증 장질환★(IBD)	[병력] 혈변, 심한 복통, 탈수, 체중 감소 [검진] 복부 압통, 장음 감소, DRE 혈변	[검사] 대장내시경, 대장조영술, 복부 CT [치료] 설파살라진, 스테로이드, Infliximab, 충분한 영양 공급
	치핵★ / 항문 열창★	[병력] 휴지에 묻어나오는 정도의 피, 항문 통증, 변비 [검진] DRE 소견에서 항문 치핵/열상	[검사] 대장내시경 [치료] 보존적 치료, 치핵절제술, 좌욕 치료(배변 직후 물 40c/5~10min/하루 3~4번)
소화성 궤양 질환		[병력] 식전, 식후 속쓰림, 소화불량, 상복부 압통	[치료] PPI, NSAID 중단, <i>H. pylori</i> 제균, 금주, 금연

소아 대장 질환	중장염전 (Midgut volvulus)	[병력] 생후 1개월 내, 담즙성 구토, 토혈, 혈변 [검진] 복부팽만	[검사] 복부 X선, 복부 CT, 상부위장관조영술 [치료] 초음급 수술 : 꼬인장 풀기
	창자겹침증 (Intussusception)	[병력] 5개월~6세, 주기적 복통, 혈성 점액 대변, 담즙성 구토 [검진] 복부덩이	[검사] 복부초음파, 관장 [치료] 금식, 관장(정복술), 수술(외과적 정복술)

증례별 알고리즘



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 혈변을 보셨나요?
L	-
D	얼마나 자주 혈변을 보셨나요?
Co	혈변이 점점 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 증상이 있으셨나요?
C	출혈량이 얼마나 되나요? (변기에 가득 고임/뚝뚝 떨어짐/휴지에 묻는 정도) 색깔은 어떤가요? (선홍색/검붉은색) 변의 양상 : 변이 끈적끈적한가요? (점액성) 일상 생활에 지장이 있나요?
A	[전신] 발열/오한/피로/체중 변화 [과다 출혈] 목마름/호흡곤란/두근거림/어지럼/소변량 감소가 있나요? 암기법 마른 호두를 어지럽힌 소감 설명 마른(목마름) 호두(호흡곤란, 두근거림)를 어지럽힌(어지럼) 소감(소변량 감소) [출혈 경향] 멍이 잘 드나요?/양치하다 피가 났나요?/생리량이 많아졌나요? [소화기] 식욕 저하/구역/구토/설사/변비/복통/토혈/흑색변 [결장/직장암] 뒤통변/변괴기 변화/복부 종괴가 있나요? [치핵/항문 열창] 배변 시 항문 통증/튀어나오는 덩이가 있나요? 암기법 뒤로 통통 튀는 복덩이 설명 뒤로(뒤통) 통통(항문 통증) 튀는(튀어나온 덩이) 복덩이(복부 종괴) [간질환] 황달이 있나요? + 황달이 있는 경우 : 가려움, 복수, 소변색/대변색 변화
F	최근에 과음, 과식 하셨나요?/최근에 해외여행 간 적 있나요?
E	이전에 건강 검진 해보셨나요?/대장내시경도 하셨나요?
외	복부나 항문 수술을 받으신 적 있나요? 복부나 항문을 다친 적 있나요?

과	이전에 고혈압/당뇨/간질환 진단받은 적 있나요? 협심증같은 심장 질환과 항문 질환을 진단받은 적 있나요?
약	복용 중인 약물이 있나요? (아스피린, 항혈소판제, NSAID)
사	술, 담배, 커피는 하시나요?/직업이 어떻게 되시나요? [식습관] 평소 식사는 규칙적으로 하세요?/기름지고 자극적인 음식을 좋아하시나요? [운동] 운동은 규칙적으로 하시나요?/일주일에 몇 번 정도 하세요?
가	가족 중 비슷한 증상 있는 분 있나요? 가족 중 소화기계 관련 질환 있으신 분 있었나요? 가족 중 대장암을 앓으신 분 있었나요?
여	[월경력] LMP/규칙적/주기/생리량/생리통/임신 가능성
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [출혈★] 혈압, 맥박 보고 응급인지 확인하는게 먼저! [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 입 : 혀(탈수) 3. 목 : 경부 림프절 촉진(대장암 전이) 4. 피부★ : 피부 긴장도(탈수) [누워서] 5. 복부★ : 시진 수술 흔적, 팽만/청진 5구역 3초간/타진 4군데 이상/ 촉진 알, 깊 촉진 ⊕ 황달 있거나 간질환 의심 시 : 간, 비장 타진 및 촉진 6. DRE : 직장수지검사
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 항문 직장 진찰(DRE) 2. 혈압 측정 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	변에서 피가 나와서 많이 놀라셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 A질환이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 그 외에 B질환, C질환도 완전히 배제할 수 없습니다. (대장암 가능성 반드시 설명!!)

검사	따라서 정확한 진단을 위해 대장내시경, 복부 CT, 전체혈구검사가 필요할 것으로 보입니다. 대장내시경은 금식과 관장약 복용 등 준비가 필요한 검사입니다. 준비 과정이 힘들고 검사가 불편할 수 있지만 진단을 위해 꼭 필요한 검사입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 검사로 A질환이 확진되면 치료를 위해 금식 or 약물 치료 or 수술적 치료가 필요할 수 있습니다. [응급] (출혈량이 많거나 빈혈 증상을 보일 경우) 출혈량이 많아 응급 상황으로 수액 공급 및 수혈이 필요합니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[양성 질환] 양성 질환의 경우 식이 섬유를 골고루 섭취하는 식습관과 변기에 오래 앉아 있지 않는 배변 습관, 주기적 운동을 하는 것이 개선에 도움이 됩니다. [건강 검진] (나이가 있거나 위험 인자가 있는 경우) 환자분의 경우 대장암 위험 인자가 있어 대장내시경을 통해 기질성 질환의 감별이 필요하며, 만 50세 이상인 경우 국가암검진 프로그램에 참여해 매년 분변 잠혈검사를 하고, 이상 시 대장내시경검사를 받으실 수 있으니 정기 검진을 권유드립니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 대장내시경, 위내시경, 혈관조영술
- ② 혈액검사 : CBC, electrolyte, LFT, BUN/Cr, 혈액응고검사
- ③ 영상검사 : 복부 X-ray, 복부 CT

❖ 치료 계획

- ① IV line 확보, 수액 공급, 산소 공급, 내시경적 지혈술, 혈관내색전술, 동반된 응고 이상 교정
- ② 대장암/직장암 : 수술적 절제 및 항암 치료
- ③ IBD : 스테로이드 등 약물 치료, 충분한 영양 공급, 합병증 발생 시 수술적 치료
- ④ Ischemic colitis : 금식(보존적 치료), 기저 질환 관리

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 환자 안심

 "파가 나와 놀라셨을 텐데 빨리 잘 오셨습니다. 바르게 도와드리겠습니다" 로 라벨을 씌도록 합니다.